

SCHEDA / CONTESTO E FONTI

Contesto della raccolta

Non è un'autorizzazione al pasto: riporta le informazioni pertinenti e ciò che resta da chiarire.

Codice persona / età

Professionista / servizio

Data/e e orario dell'osservazione

Data di compilazione / pasto P_____

Domanda osservativa e priorità della persona / caregiver

Luogo, tipo di pasto, persone presenti

Fonte: dal vivo / registrazione / riferita / documentale

Indicazioni cliniche e alimentari vigenti: fonte, autore, data e riferimento

Riporta quanto pertinente: eventuali limitazioni orali, consistenze previste, assistenza e piano individuale. Non generare indicazioni con OPA.

Allergie / restrizioni pertinenti e fonte

Informazioni cliniche nuove o non chiarite

Accesso e volontà: modalità per scegliere, chiedere aiuto, rifiutare e segnalare dolore

Stato iniziale osservabile e comfort riferito

Referente / percorso di assistenza del setting

Raccolta effettuata: ☐ pasto osservato ☐ osservazione parziale ☐ sole informazioni ☐ rinviata/interrotta

Motivo della raccolta parziale / rinvio; informazioni da verificare

Prima dell'osservazione: leggere G3

Non introdurre assaggi se l'assunzione orale non è prevista, è da chiarire o vi sono nuovi dubbi clinici. Non usare la scheda per ignorare indicazioni o rifiuto. In caso di segni preoccupanti, la gestione della persona viene prima della compilazione.

SCHEDA / PANORAMICA

Il pasto in sintesi

Una nota per le aree esplorate. Le pagine successive sono approfondimenti selezionabili.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

Intervallo effettivamente osservato

Alimenti A _____ / fonte e periodo delle informazioni

AREA / DETTAGLIO	EVIDENZA ESSENZIALE, CONDIZIONI E FONTE
Setting, postura, autonomia S4	
Alimenti e bevande presenti S3	
Accettazione, repertorio, esplorazione S5	
Morso, masticazione, gestione orale S6–S7	
Tempi, pause, fatica S8	
Persona, caregiver e strategie S9	
Eventi, interruzioni e azioni S10	

Limiti della panoramica: che cosa non è stato esplorato o non era osservabile

Approfondimenti utilizzati: _____

Una riga vuota non significa abilità assente. “Non rilevato” va riferito a un segno e a un intervallo specifici; non significa rischio assente. L’esito non è “sicuro / non sicuro”. Sintesi professionale: S12.

SCHEDA / REGISTRO RIPETIBILE

Alimenti e bevande osservati

Descrivi le preparazioni effettivamente presenti. Non è una proposta di alimenti da somministrare.

Codice persona: _____ Pasto P_____ Data/e: _____

A Alimento / bevanda A_____ — registrazione ripetibile

Denominazione, componenti e preparazione

Presentazione, utensile e assistenza

Caratteristiche osservate: forma/dimensioni, parti solide/liquide, temperatura e fonte

Offerto / rimasto / disperso / apparentemente assunto

Misura, stima o riferito? Metodo e limiti

IDDSI previsto dal piano, se presente: livello / fonte

Eventuale livello dichiarato o verificato: autore / data / ref.

Fonte del dato sul preparato: ☐ piano soltanto ☐ etichetta ☐ verifica documentata ☐ non disponibile

A Alimento / bevanda A_____ — registrazione ripetibile

Denominazione, componenti e preparazione

Presentazione, utensile e assistenza

Caratteristiche osservate: forma/dimensioni, parti solide/liquide, temperatura e fonte

Offerto / rimasto / disperso / apparentemente assunto

Misura, stima o riferito? Metodo e limiti

IDDSI previsto dal piano, se presente: livello / fonte

Eventuale livello dichiarato o verificato: autore / data / ref.

Fonte del dato sul preparato: ☐ piano soltanto ☐ etichetta ☐ verifica documentata ☐ non disponibile

Descrivere non equivale a classificare o attestare sicurezza

“Morbido” o “cremoso” non sono livelli IDDSI. Non dedurre il livello dall’aspetto e non confondere quello previsto con una verifica del preparato. OPA non effettua test IDDSI. Quantità visibili o stimate non misurano automaticamente l’apporto deglutito, nutrizionale o idrico. Guida: G4.

SCHEDA / SETTING E AUTONOMIA

Postura, utensili e assistenza

Annota azioni e supporti effettivi, non un livello globale di dipendenza.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

01 Setting e postura

Seduta, appoggi e posizione iniziale osservabile

Tavolo, raggiungibilità, luce, rumore e presenti

Cambiamenti durante il pasto: momento, autore, motivo e indicazione vigente richiamata

Descrivi quanto visibile; non valutare con OPA una postura "corretta" universale e non proporre manovre compensatorie.

02 Autonomia e utensili

AZIONE / UTENSILE	CHE COSA FA LA PERSONA	AIUTO EFFETTIVO / CHI / QUANDO
Scelta e accesso		
Presa / preparazione		
Trasporto alla bocca		
Pausa / fine / altro		

Informazioni riferite: fonte, periodo e differenze rispetto a questo pasto

Gli ausili abituali non sono errori. Documenta chi avvia le azioni e quali passaggi restano autonomi. Guida: G5.

SCHEDA / ACCETTAZIONE E REPERTORIO

Esplorazione, scelta e rifiuto

Nessuna sequenza obbligata: osservare o toccare non implica dover assaggiare.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

03 Episodio diretto — E _____ / alimento A _____

Che cosa precede e che cosa fa la persona: azione, parola, gesto o altro segnale

Proposta / spontaneo; chi propone e in quale modo

Risposta del partner e prosecuzione o interruzione

Caratteristiche del cibo/contesto associate all'episodio; incertezze sulla relazione

Non usare "oppositivo" o una causa sensoriale come sostituti del fatto osservato. Non introdurre pressioni, privazioni o assaggi per riempire la scheda.

04 Repertorio abituale — informazione riferita

Fonte / ruolo: _____ Periodo e contesti: _____

ALIMENTO / PREPARAZIONE	QUANDO, DOVE E COME È ASSUNTO O RIFIUTATO

Vincoli riferiti, preferenze, alternative disponibili e informazioni mancanti

Separare abitudini riferite e alimenti osservati. Nessun numero di cibi definisce una diagnosi o la qualità della dieta. Guida: G6.

SCHEDA / AZIONI ORALI VISIBILI

Morso e masticazione

Documenta il campione, senza introdurre consistenze o porzioni per mettere alla prova l'abilità.

Codice persona: _____ Pasto P_____ Data/e: _____

Alimento A_____ / episodio E_____ / fonte

Preparazione, porzione presentata, utensile e aiuti

05A Morso: che cosa è effettivamente richiesto e visibile?

☐ osservato ☐ non esplorato ☐ non osservabile ☐ non pertinente al cibo/pasto

Modalità di introduzione / eventuale distacco di una porzione; azioni della persona e del partner

Limiti della visibilità e circostanze: alimento già porzionato, presa, comfort riferito, altro

05B Masticazione: movimenti, pause e variazioni

Movimenti mandibolari visibili, eventuali asimmetrie, frammenti e pause nel campione

Momento / durata se misurata / conteggio facoltativo

Metodo, supporti, parti non osservabili

Confronto entro il campione e informazioni riferite, mantenendo distinte le fonti

Un movimento visibile non dimostra l'intero processo

Non dedurre efficacia di triturazione, forza, maturità o sicurezza della deglutizione. Nessuna soglia di tempo o di masticazioni. Non forzare l'apertura della bocca per osservare. Guida: G7.

SCHEDA / GESTIONE ORALE

Bolo, perdite e residui visibili

“Non visibile” non equivale a “assente”. Non descrivere residui faringei da un’osservazione esterna.

Codice persona: _____ Pasto P_____ Data/e: _____

Alimento A_____ / episodio E_____ / fonte

Momento e modalità di osservazione; limiti di visibilità

06A Contenimento e movimenti effettivamente osservabili

Che cosa si vede: chiusura labiale, movimenti orali, perdite anteriori o espulsione

Sequenza, permanenza visibile e risposta spontanea; che cosa non è osservabile

06B Eventuale residuo orale visibile

MOMENTO / ALIMENTO	SEDE VISIBILE E DESCRIZIONE	AZIONE SPONTANEA / SEGUITO

Informazioni riferite o documentali su residui: fonte, data e sede riportata

Limite della scheda

Non introdurre dita o utensili e non forzare un’ispezione per completare OPA. Non usare l’assenza di residui visibili, tosse o altri segni per attestare la sicurezza della deglutizione. Un intervento clinico necessario segue le procedure appropriate, non le istruzioni di compilazione. Guida: G3 e G7.

SCHEDA / ANDAMENTO TEMPORALE

Tempi, pause e affaticamento

Distingui l'intervallo osservato dall'intera durata del pasto e la fatica riferita da ciò che vedi.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

Inizio/fine del pasto, se noti — fonte

Intervallo osservato — modalità di rilevazione

Situazione iniziale / comfort riferito

Assunzioni o pause precedenti, se note — fonte

MOMENTO	AZIONE, PAUSA O CAMBIAMENTO	FORTE / MOTIVO RIFERITO / RISPOSTA

Fatica, dolore, fame o sazietà riferiti dalla persona: parole / segnale e modalità comunicativa

Cambiamenti osservati e limiti: cosa può essere descritto senza attribuirne la causa

Motivo e autore della conclusione / interruzione

Eventuali eventi richiamati in S10 — E _____

Non usare durata o numero di assunzioni come soglia di normalità. Le pause possono avere motivi differenti. Segni nuovi o preoccupanti richiedono gestione appropriata, non ulteriori prove per completare il confronto. Guida: G3 e G8.

SCHEDA / PERSONA E CAREGIVER

Comunicazione, aiuti e strategie

Mantieni distinta la prospettiva della persona da quella del partner.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

09 Interazione nel pasto — episodio E _____

Segnale della persona: scelta, richiesta, rifiuto, altro

Risposta del partner: parole, attesa, aiuto e contesto

Partecipazione e comportamento descritti senza attribuire intenzioni o cause

10 Strategie spontanee o già previste — non una prova di trattamento

AZIONE / CHI LA AVVIA	CONDIZIONI PRIMA / DOPO	RISULTATO VISIBILE E LIMITI

Preferenze e impatto riferiti dalla persona

Esperienza, bisogni e carico riferiti dal caregiver

Indicazioni vigenti richiamate / informazioni da condividere con il referente

Un risultato apparentemente favorevole non dimostra sicurezza deglutitoria. Non trasferire automaticamente una strategia ad altri cibi o persone. La scheda non prescrive postura, utensili, addensanti, volumi o manovre. Guida: G9.

SCHEDA / EVENTI E AZIONI · RIPETIBILE

Evento, interruzione e comunicazioni

La gestione della persona viene prima della documentazione. Guida: G3 e G8.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

Non attendere un esito OPA

In caso di emergenza, attiva immediatamente i soccorsi e le procedure locali. Se compaiono segni nuovi o preoccupanti durante l'assunzione, interrompi l'offerta e attiva il referente secondo il piano del servizio. Non fare nuovi assaggi per confermare o escludere il problema.

Episodio E _____ / ora o fase del pasto

Fonte: diretta / riferita / documentale; autore e data

Che cosa precede l'evento: alimento A _____, posizione, utensile, aiuto e stato iniziale

Fatto osservato o parole riferite: descrizione, andamento e cambiamento rispetto all'inizio

Azioni adottate, da chi e quando; eventuale interruzione dell'offerta e dell'osservazione

Chi è stato contattato / ora / modalità

Risposta, indicazione ricevuta / autore / data

Seguito documentato, informazioni ancora da verificare e responsabilità del passaggio

Professionista / firma: _____

L'evento non costituisce una diagnosi; la scheda non autorizza la ripresa del pasto. Assenza di tosse o cessazione del segno non dimostrano assenza di aspirazione. Conservare il riferimento al piano o alla decisione clinica pertinente.

SCHEDA / CONFRONTO FACOLTATIVO

Pasti e contesti a confronto

Confronta solo ciò che è documentato, senza cambiare il pasto per costruire il confronto.

Codice persona: _____ Data di compilazione: _____

CHE COSA CONFRONTO	PASTO / SITUAZIONE A	PASTO / SITUAZIONE B
Codice, data, fonte e periodo		
Luogo, partner, momento e durata osservata		
Alimento, preparazione, utensile e piano richiamato		
Setting, supporti, assistenza e stato iniziale		
Azioni della persona, pause e partecipazione		
Eventi, interruzioni e azioni documentate		

Che cosa è confrontabile e quali differenze impediscono una conclusione

Domanda da approfondire e dati necessari, senza provocare nuove prove

Un resoconto domestico e un episodio diretto nel servizio non sono misure equivalenti. Non sommare risultati o ricavare miglioramento, peggioramento o sicurezza da condizioni differenti. Guida: G9.

SCHEDA / SINTESI PROFESSIONALE

Profilo osservativo del pasto

Sintesi qualitativa, senza punteggi e senza conclusioni automatiche sulla deglutizione.

Codice persona: _____ Data di compilazione: _____

Ambito: pasti, alimenti, fonti, periodi e pagine utilizzate

Risorse osservate e condizioni che hanno favorito autonomia e partecipazione

Bisogni, variabilità, limiti e informazioni mancanti

Sintesi del professionista — collegare i fatti alle fonti, senza attribuire una diagnosi con OPA

Priorità della persona / caregiver, con fonte

Eventi e azioni già documentati — riferimenti S10

Aspetti da approfondire, referenti, responsabilità e tempi concordati per il seguito

Documenti collegati: _____

Professionista / firma: _____

Questa sintesi non attesta la sicurezza del pasto

Non esclude disfagia o aspirazione e non sostituisce valutazione clinica, esami strumentali quando indicati o protocolli validati. Non equivale a prescrizione di dieta, consistenze, volumi o assistenza. Le decisioni cliniche vanno documentate nei percorsi appropriati.